

Psychiatrie

1. MOTIF DE CONSULTATION

2. ELEMENTS ANAMNESTIQUES

- **Anamnèse actuelle**

- Explorer les plaintes principales du patient et les symptômes actuels
- Investiguer le contexte d'apparition du problème et des symptômes : début, durée, intensité, évolution et présence d'évènements déclencheurs.
- Explorer les répercussions du problème et des symptômes dans la vie du patient, notamment dans les sphères sociales, familiales et professionnelles.

- **Antécédents psychiatriques personnels**

- Investiguer les antécédents d'hospitalisation en milieu psychiatrique, de suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire et l'historique des traitements psychotropes.

- **Antécédents psychiatriques familiaux**

- Investiguer la présence de pathologies psychiatriques héréditaires ou non dans la famille.
- Investiguer comment le patient l'a vécu, l'impact sur lui

- **Anamnèse socioprofessionnelle et familiale**

- Profession (certaines professions sont plus à risque d'épuisement), activité occupationnelle ou source de revenu (Revenu d'Insertion, Assurance Invalidité, chômage). Activités de la vie quotidienne, loisirs.
- Mode et lieu de vie (seul, en famille, en couple, en institution, sans domicile).
- Entourage social et familial (nature des liens familiaux, nature des liens sociaux, relation sentimentale ou conjugale).

- **Antécédents médicaux et habitudes**

- Rechercher les affections somatiques, les traitements médicaux (tous, corticoïde) actuels y compris psychotropes et les allergies.
- Aborder la question de la consommation d'alcool, de tabac et d'autres toxiques : sevrage – intoxication
- Addictions sans substance : jeux d'argent, gaming, réseaux sociaux, TCA, trouble du comportement sexuel

3. STATUS PSYCHIATRIQUE

- **A. Présentation, psychomotricité et contact relationnel**
 - Corpulence, tenue vestimentaire (soignée, négligée, neutre, excentrique), hygiène, posture, démarche, ralentissement, agitation, mimique.
 - Contact et relation
- **B. Troubles cognitifs**
 - Vigilance.
 - Orientation sur les 4 modes (temps, espace, à la situation, à sa personne).
 - Attention (focus attentionnel, partage le regard), concentration, mémoire.
- **C. Pensée et discours**
 - Ton (monotone, exalté), débit de parole (logorrhée, laconisme).
 - Cours de la pensée (accélération de la pensée, fuite des idées, réponses à côté, coqs à l'âne, désorganisé).
 - Contenu de la pensée (cohérence, logique, informations, thématique).
- **D. Délire, troubles du moi et des perceptions**
 - Idées prédélirantes, idées délirantes (thématique, systématisation, implication affective – est-ce qu'il y adhère ? – critique ?).
 - Déréalisation (=réel perçu comme irréel, comme un film), dépersonnalisation (se voit de l'extérieur), pensées imposées (automatisme mental).
 - Illusions, hallucinations (visuelles : poursuite oculaire, acoustico-verbales : attitude d'écoute, cénesthésiques, olfactives, gustatives), fréquence des hallucinations, participation affective, description
- **E. Thymie / humeur et affects**
 - Humeur abaissée - neutre - élevée, anhédonie, aboulie, manque de motivation, sentiment d'insuffisance, baisse de l'estime de soi, honte, culpabilité
 - Humeur émoussée, abrasée (perte d'émotion)
 - Affects congruents à l'humeur, discordance affective, labilité affective
- **F. Anxiété**
 - Tension interne, nervosité, agitation motrice
 - Obsessions, phobies (comportement d'évitement, hypervigilance), compulsions.
- **G. Idées suicidaires et hétéro-agressivité**
 - Volonté de se faire du mal, de mourir
 - Si oui : présence d'un scénario (accessibilité au moyen et létalité du moyen), imminence du scénario
- **H. Troubles somatiques et du dynamisme**
 - Troubles du sommeil, de l'appétence, gastro-intestinaux et cardio-respiratoires.

4. CONCLUSION DE L'ENTRETIEN

Dépression ECOS

Anamnèse

- Anamnèse actuelle :
 - Chronologie
 - Facteurs déclencheur couple
 - Facteur déclencheur professionnel
 - Facteur déclencheur solitude
- Anamnèse personnelle
 - Facteurs professionnels
 - Aspects financiers
 - Logements
 - Vie de couple
- Symptômes dépressifs majeurs :
 - Humeurs tristes
 - Anhédonie
 - Perte de l'élan vital ou fatigue
- DD bipolarité
 - ATCD d'humeur augmentée
 - Insomnie
 - Productivité augmentée
 - Logorrhée ou fuite des idées
 - Sensation de grandeur
 - Activité à risque
- Symptômes psychotiques
 - Hallucinations visuelles
 - Hallucinations auditives
 - Dépersonnalisation ou déréalisation
 - Devinement ou vol de la pensée
 - Délire paranoïde
- Troubles somatiques et caractérisations
- ATCD / comorbidités
 - Somatiques
 - Psychiatriques
 - ATCD TS
- Prise de substances
 - Médicaments
 - Drogues
 - Alcool
- Auto/hétéro-agression
 - Idées suicidaires
 - Risque suicidaire
 - Urgence : ou quand comment
 - Dangereux : létalité du moyen – accessibilité du moyen
 - Pensée à se faire du mal
 - Pensée à faire du mal à qqn d'autres